

Un adulte autiste âgé dans votre cabinet

Pour les médecins de famille et les professionnels de santé — soigner un adulte autiste âgé (environ 60 ans et plus).

L'idée principale

L'autisme, à travers le **monotropisme**, signifie que l'attention d'un adulte âgé s'est toujours verrouillée dans quelques « tunnels » profonds et intenses. C'est la **partie la moins étudiée du cycle de vie autistique**, et les résultats sont préoccupants : les adultes autistes âgés présentent des **taux plus élevés pour la plupart des problèmes de santé, une qualité de vie moindre et une participation sociale limitée**. Beaucoup n'ont jamais été identifiés — la « génération perdue » — et arrivent via des différences sociales/sensorielles chroniques, un burnout ou une crise. Les intérêts et routines de toute une vie sont des ancres de bien-être ; les changements de l'audition et de la vision s'ajoutent aux différences sensorielles de base.

Ce que vous pouvez observer — et ce qui se passe réellement

Vous pouvez observer...	Ce qui se passe souvent
Évite les soins, manque les rendez-vous, « n'aime pas venir »	Expériences négatives tout au long de la vie + barrières sensorielles/de communication — et non une non-observance
Déclin des compétences, épuisement, retrait	Possiblement un burnout autistique accumulé sur des décennies — souvent interprété à tort comme le « vieillissement »
Réponses lentes ou inhabituelles ; semble confus	Souvent un temps de traitement + différence autistique tout au long de la vie — pas nécessairement une démence
Routines, objets et intérêts forts ; résiste au changement	Ce sont des ancres protectrices pour l'identité et la cognition
Ne signale pas la douleur ou les symptômes	Différences d' intéroception ; « ne pas se plaindre » ≠ « ne pas souffrir »

Essayez ceci

- **Proposez l'AHAT d'AASPIRE** ; autorisez la présence d'un accompagnateur de confiance ; fournissez des informations **écrites et littérales** et laissez un temps de traitement suffisant.
- **Réduisez la charge sensorielle** et tenez compte de la perte d'audition ou de vision qui s'ajoute aux différences de base.
- **Protégez les intérêts et routines de toute une vie** ; adaptez les activités à l'évolution des capacités plutôt que de les supprimer.
- **Distinguez soigneusement la différence autistique du déclin cognitif** — les preuves sur l'autisme et la démence sont rares ; évaluez, ne supposez pas.
- **Documentez les aménagements efficaces** pour qu'ils soient automatiques lors de la prochaine visite.

Évitez ceci

- Balayer des différences sociales/sensorielles chroniques comme étant « juste le vieillissement », ou le burnout comme étant de la dépression.
- Perturber les routines ou supprimer des objets significatifs à l'hôpital ou en centre de soins.
- Supposer une incapacité cognitive à partir d'une réponse lente ou atypique — utilisez la prise de décision assistée.

Quand chercher plus de soutien

Dépistez le **burnout autistique** (souvent le fruit de plusieurs décennies) et traitez-le comme distinct de la dépression. Surveillez les **co-occurrences fréquentes** — troubles de l'humeur, sommeil, troubles gastro-intestinaux et cardiaques — qui sont plus fréquents dans ce groupe. Luttez contre l'**isolement social** (un risque majeur) et encouragez une activité douce et adaptée. Soyez transparent sur les **limites des preuves scientifiques** concernant le grand âge, et planifiez les soins futurs avec une communication claire et littérale.

Si la personne est une femme

Les femmes autistes âgées sont un groupe particulièrement sous-identifié, ayant pratiqué le masking toute leur vie. Des antécédents d'« anxiété », des erreurs de diagnostic ou un burnout, parallèlement à des différences sociales/sensorielles chroniques, justifient un examen sérieux de l'autisme.

À propos de ce guide

Assisté par IA, dérivé des brouillons de recherche du projet — la brève sur le **Monotropisme** et le **Guide pour les praticiens et les soins de santé** (Parties 3.5 & 4). Utilise le langage identitaire. **Informatif — ce n'est pas un avis médical ni un outil de diagnostic.**

Note : les preuves sur l'autisme au grand âge sont rares ; considérez ceci comme des conseils de bonnes pratiques, et soyez honnête sur les incertitudes.

Sources clés. Murray, Lesser & Lawson (2005); Dwyer (2025); Klein et al. (2024, aging & autism review); Raymaker et al. (2020); Kelly Mahler (2024); AASPIRE AHAT; OAR (aging on the spectrum). Les citations complètes se trouvent dans les brouillons sources.